



ĆWICZENIOWNIK PRAKTYCZNY

Techniki oddechowe i relaksacja na poród

przygotowanie od 30. tygodnia

Oddech · relaksacja · wizualizacja · rola partnera

PoródNaMiare.pl

Opracowanie oparte na metodyce szkół rodzenia i fizjologii oddechu
Materiał edukacyjny — nie zastępuje zajęć w szkole rodzenia ani porady położnej

Spis treści

1. Dlaczego oddech naprawdę działa	3
2. Fundament: oddech przeponowy	4
3. Technika 4-7-8 — wyciszenie i sen	5
4. Oddech w I okresie — faza utajona	6
5. Oddech w fazie aktywnej	7
6. Faza przejściowa — najtrudniejszy moment	8
7. II okres porodu — oddech przy parciu	9
8. Relaksacja progresywna Jacobsona	10
9. Rola partnera — wspólny oddech	11
10. Plan ćwiczeń na III trymestr	12

Jak korzystać z przewodnika

Ćwicz od 30. tygodnia ciąży — technika opanowana wcześniej działa automatycznie w stresie porodowym.

Partner powinien znać te techniki równie dobrze jak Ty — to on będzie przypominał o nich w trakcie porodu.

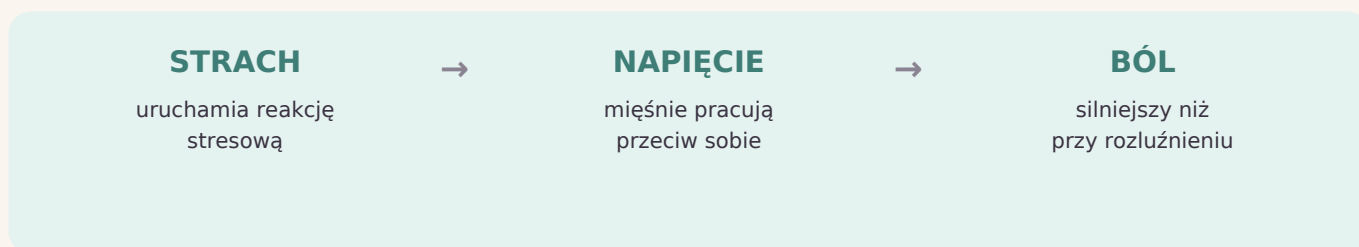
Dlaczego oddech naprawdę działa

Oddech to jedyna funkcja autonomiczna, którą możesz świadomie kontrolować — i przez to wpływać na cały układ nerwowy. To nie jest „technika relaksacyjna” w sensie miękkim. To mierzalna fizjologia.

Co dzieje się w ciele przy spokojnym oddechu

- Aktywacja układu przywspółczulnego — spowolnienie tętna, obniżenie ciśnienia, rozluźnienie mięśni.
- Spadek poziomu kortyzolu i adrenaliny, które hamują wydzielanie oksytocyny — hormonu skurczów.
- Lepsze dotlenienie macicy i dziecka — skurcze są bardziej efektywne, a zapis KTG stabilniejszy.
- Przerwanie błędnego koła: ból → napięcie → silniejszy ból. Rozluźnione mięśnie bolą mniej.

Kluczowa zależność: strach — napięcie — ból



Świadomy oddech przerywa ten cykl w najłagodniejszym ogniwie — napięciu. Nie usuwa bólu, ale zapobiega jego wzmacnianiu.

Fundament: oddech przeponowy

Wszystkie pozostałe techniki opierają się na tej jednej. Większość dorosłych oddycha płytko, górną częścią klatki piersiowej — to wzorzec stresowy. Oddech przeponowy trzeba świadomie przywrócić.

Nauka oddechu przeponowego

PODSTAWA

POZYCJA

Półożenie oparte o poduszki lub siad na piłce. Jedna dłoń na klatce piersiowej, druga na brzuchu poniżej żeber.

WYKONANIE

Wdech nosem 4 sekundy — unosi się TYLKO dłoń na brzuchu, dłoń na klatce pozostaje nieruchoma. Wydech ustami 6 sekund, brzuch opada. Wydech zawsze dłuższy niż wdech.

Ćwicz 5 minut dziennie od 30. tygodnia. Cel: oddech przeponowy ma stać się automatyczny.

Najczęstsze błędy

BŁĄD 1

Unoszenie ramion przy wdechu — to oddech górnożebrowy, wzmacnia napięcie zamiast je redukować.

BŁĄD 2

Zbyt głęboki, forsowny wdech — prowadzi do hiperwentylacji (zawroty głowy, mrowienie palców). Oddech ma być spokojny, nie maksymalny.

Technika 4-7-8 — wyciszenie i sen

Opracowana przez dr. Andrew Weila technika o silnym działaniu wyciszającym. W ciąży przydatna wieczorem przy problemach z zasypianiem oraz w fazie utajonej porodu, gdy warto oszczędzać siły.

Schemat 4-7-8

- 4** WDECH nosem — licz do 4
- 7** ZATRZYMAJ oddech — licz do 7
- 8** WYDECH ustami — licz do 8, z dźwiękiem „szszsz”

Zasady stosowania

- Zaczynaj od 4 cykli. Po 2 tygodniach regularnego ćwiczenia możesz zwiększyć do 8 cykli.
- W ciąży, jeśli zatrzymanie oddechu na 7 sekund jest niekomfortowe — skróć proporcjonalnie (3-5-6). Rytm jest ważniejszy niż konkretne liczby.
- Nie stosuj podczas skurczów w fazie aktywnej — wtedy potrzebujesz oddechu ciągłego, nie z zatrzymaniem.

Oddech w I okresie — faza utajona

Faza utajona (rozwarcie do ok. 4–5 cm) bywa najdłuższa — nawet kilkanaście godzin. Skurcze są znośne, co 10–20 minut. Największy błąd na tym etapie: nadmierne zaangażowanie i wyczerpanie sił na starcie.

Oddech spokojny, powolny

KIEDY

Od pierwszych regularnych skurczów do rozwarcia ok. 4–5 cm.

JAK

Oddech przeponowy w naturalnym tempie. Wdech nosem 4 s, wydech ustami 6 s. Podczas skurczu utrzymuj ten sam rytm — nie przyspieszaj. Między skurczami wróć do zwykłego oddychania i odpoczywaj.

Cel tej fazy to OSZCZĘDZANIE ENERGII. Jedz lekko, pij, drzemij, chodź. Nie „pracuj” jeszcze z każdym skurczem.

Co jeszcze robić w fazie utajonej

- Zmieniaj pozycje — chodzenie i kołysanie biodrami wspomagają zstępowanie dziecka.
- Ciepły prysznic lub kąpiel — działa przeciwbólowo i rozluźniająco.
- Odpoczywaj między skurczami. Jeśli poród zaczął się w nocy — próbuj spać.

Oddech w fazie aktywnej

Faza aktywna (rozwarcie 5–8 cm) — skurcze co 3–5 minut, trwają 45–60 sekund, wyraźnie bolesne. Tu oddech staje się głównym narzędziem pracy.

Oddech „falą” — dopasowany do skurczu

POCZĄTEK SKURCZU

Głęboki wdech nosem, długi wydech ustami — sygnał „zaczynamy” dla ciała i partnera.

SZCZYT SKURCZU

Oddech nieco płytszy i szybszy, ale RÓWNY — wdech nosem 2 s, wydech ustami 2 s. Wydech przez lekko zaokrąglone usta, jakbyś dmuchała na świeczkę, nie gasząc jej.

Po skurczu: jeden głęboki oddech oczyszczający i pełne rozluźnienie. Skurcz minął — nie myśl o następnym.

Dźwięk jako narzędzie

DLACZEGO WARTO

Niski, głęboki dźwięk („aaaa”, „ooooo”) na wydechu rozluźnia szczękę, a przez połączenie powięziowe — także dno miednicy.

CZEGO UNIKAĆ

Wysokich, piskliwych dźwięków i krzyku — napinają szczękę i dno miednicy, działając przeciwnie do zamierzenia.

Faza przejściowa — najtrudniejszy moment

Rozwarcie 8–10 cm. Najkrótsza (15–60 minut), ale najintensywniejsza faza. Typowe: drżenie, mdłości, uczucie utraty kontroli, myśl „nie dam rady”. Paradoksalnie — te objawy oznaczają, że jesteś blisko końca.

Oddech przerywany („sz-sz-fu”)

KIEDY

Gdy pojawia się przedwczesne parcie, a położna mówi „jeszcze nie przyj” — rozwarcie nie jest pełne.

JAK

Dwa krótkie wydechy przez lekko rozchylone usta („sz-sz”), potem jeden dłuższy dmuchnięty wydech („fu”). Powtarzaj rytmicznie przez cały skurcz. Ten wzorec fizycznie utrudnia parcie.

Parcie przy niepełnym rozwarcu może spowodować obrzęk szyjki i wydłużyć poród — dlatego ta technika jest tak ważna.

Wsparcie w tej fazie

- Partner: oddychaj RAZEM z nią, patrząc w oczy. Ona ma powtarzać Twój rytm, nie odwrotnie.
- Krótkie, konkretne komunikaty: „oddychaj ze mną”, „już blisko”, „świetnie ci idzie”.
- To normalne, że w tej fazie rodząca może być opryskliwa lub prosić o przerwanie porodu — nie odbieraj tego osobiście.

II okres — oddech przy parciu

Rozwarcie pełne, pojawia się nieodparta potrzeba parcia. Współczesne położnictwo zaleca parcie spontaniczne, zgodne z odczuciem — nie na komendę i nie z wstrzymanym oddechem.

Parcie spontaniczne z otwartą głością

ZALECANE

Weź wdech, przyj wraz z odczuwaną potrzebą, wypuszczając powietrze z niskim dźwiękiem lub przez lekko otwarte usta. Zwykle 3–4 krótsze parcia w trakcie jednego skurczu, każde 5–6 sekund.

NIEZALECANE (manewr Valsalvy)

Głęboki wdech, wstrzymanie oddechu i parcie „w dół” przez 10 s na komendę — zmniejsza dotlenienie dziecka i zwiększa ryzyko urazów krocza.

Jeśli personel prosi o parcie na komendę — możesz zapytać, czy w Twojej sytuacji parcie spontaniczne jest możliwe.

Moment wynurzania główki

KLUCZOWY MOMENT

Gdy położna mówi „nie przyj, dmuchaj” — główka wynurza się i tkanki krocza potrzebują czasu na rozciągnięcie.

CO ROBIĆ

Krótkie, szybkie oddechy przez usta („dmuchanie na świeczkę”) — uniemożliwiają parcie. To ta chwila decyduje o tym, czy krocze pęknie.

Relaksacja progresywna Jacobsona

Metoda polegająca na świadomym napinaniu i rozluźnianiu kolejnych grup mięśni. Uczy rozpoznawania napięcia w ciele — umiejętności kluczowej podczas porodu, gdy napięcie pojawia się nieświadomie.

Sekwencja podstawowa (10-15 minut)

ZASADA

Napnij grupę mięśni na 5 sekund (ok. 70% siły — nie do bólu), następnie rozluźnij na 15 sekund, obserwując różnicę odczuć.

KOLEJNOŚĆ

Stopy → łydki → uda → pośladki → dłonie → przedramiona → ramiona → barki → szyja → szczęka → czoło. Zawsze od dołu ku górze, po jednej grupie.

Pomiń mięśnie brzucha — w ciąży ich napinanie jest niewskazane.

Zastosowanie w porodzie

- Między skurczami: szybki „skan ciała” — sprawdź barki, szczękę i dłonie. To tam napięcie kumuluje się najczęściej.
- Rozluźniona szczęka = rozluźnione dno miednicy. Te struktury są ze sobą powiązane powięziowo.
- Partner może sprawdzać: dotknij jej barku — jeśli jest twardy, przypomnij o rozluźnieniu.

Rola partnera — wspólny oddech

Rodząca w silnym bólu traci zdolność samodzielnego utrzymania rytmu oddechu. Wtedy partner staje się metronomem — to jedno z najbardziej konkretnych zadań taty na sali porodowej.

Technika prowadzenia oddechu

POZYCJA

Ustaw się na wysokości jej twarzy, w polu widzenia. Utrzymuj kontakt wzrokowy.

JAK PROWADZIĆ

Oddychaj GŁOŚNO i wyraźnie w tempie, które chcesz uzyskać. Powiedz: „patrz na mnie, oddychaj ze mną”. Twój oddech ma być spokojniejszy niż jej — ona podąży za Twoim rytmem.

Nie mów „uspokój się” ani „nie krzycz”. Zamiast tego dawaj konkretne instrukcje: „wdech... i wydech...”.

Czego partner nie powinien robić

- Nie przypominaj o technikach w środku szczytu skurczu — poczekaj na przerwę między skurczami.
- Nie panikuj przy zmianie jej nastroju — drażliwość w fazie przejściowej to norma fizjologiczna.
- Nie zapominaj o własnym oddechu — Twoje napięcie udziela się jej natychmiast.

Plan ćwiczeń na III trymestr

Technika opanowana automatycznie zadziała w stresie. Ćwiczona pierwszy raz na sali porodowej — nie.

TYDZIEŃ	FOKUS	ĆWICZENIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ
30-32 tc.	Fundament	Oddech przeponowy — 5 min dziennie	codziennie
32-34 tc.	Wyciszenie	Oddech przeponowy + technika 4-7-8 wieczorem	codziennie
34-36 tc.	Fazy porodu	Ćwicz oddech fazy aktywnej — symuluj skurcz 60 s	4×/tydz.
36-38 tc.	Z partnerem	Wspólny oddech + relaksacja Jacobsona	3×/tydz.
38+ tc.	Utrwalenie	Wszystkie techniki + oddech „sz-sz-fu”	codziennie

Zapisz to w planie porodu

Preferencję parcia spontanicznego zamiast na komendę oraz prośbę o możliwość swobodnego oddychania i wydawania dźwięków możesz zapisać w swoim planie porodu.

Materiał edukacyjny — nie zastępuje zajęć w szkole rodzenia ani indywidualnej porady położnej. Przy ciąży powikłanej skonsultuj plan ćwiczeń z lekarzem prowadzącym.